

Ureterolitíase · cólica e critérios de drenagem

Cólica nefrética típica: dor lombar em cólica + hematúria. Analgesia potente é prioridade; infecção com obstrução = drenagem de urgência.

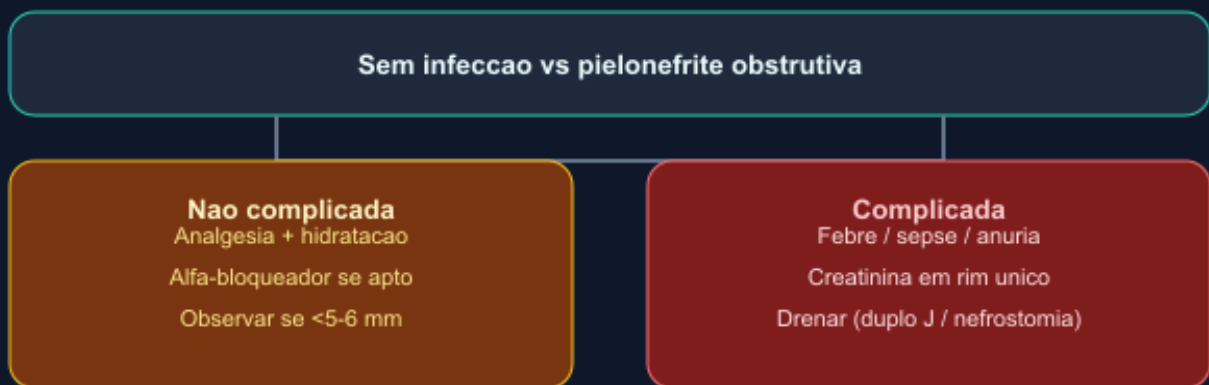
Diagnóstico

Lembre - Diagnóstico

TC sem contraste é o padrão-ouro. USG + Rx úteis na gestante/criança ou follow-up. Hematuria ajuda, mas ausência não exclui.

A bifurcação que salva rim e vida: febre + obstrução não espera eliminação espontânea.

Calculo ureteral



Conduta

- AINE (se função renal OK) ± opioide; antiemético
- Cálculos >5 mm: alta chance de eliminação; orientar filtro e retorno se febre
- <5-10 mm ou proximal persistente: maior chance de intervenção urológica
- Metafilaxia: análise do cálculo, volume hídrico, metabólico selecionado

Indicações de drenagem urgente

Indicação | Motivo

Pielonefrite obstrutiva | Risco de sepse
Anúria / rim único | Insuficiência renal
Dor refratária | Falência do conservador
Creatinina em elevação | Obstrução significativa

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Cólica + febre + dilatação piélica: ATB e desobstrução — não alta com 'analgésico e água'. AAA roto pode mimetizar cólica no idoso.